ASST Orobica Occidentale
Presidio Ospedaliero Santa Grata
U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Centro MICI - Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali
Direttore: Prof. Alberto Sala

Via Borgo Palazzo 205
24125 Bergamo
Centro MICI 035 4021877
Fax 035 4021890
mici@asst-orobica.example.it

REFERTO DI VISITA GASTROENTEROLOGICA - CENTRO MICI

Visita di controllo (cod. 89.01) e consulenza multidisciplinare chirurgica e anestesiologica

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**DELL'ORTO**
Nome:	**BIANCA**
Nata a / il:	**Bergamo, 02/12/1995**
Residenza:	**Via San Bernardino 71/C, 24126 Bergamo**
Telefono:	**+39 348 117 6620**
Professione:	**educatrice di asilo nido**
MMG:	**Dott. Roberto Carminati**

C.F. D L L B N C 9 5 T 4 2 A 7 9 4 Z

Data visita:	09/07/2025
Prenotazione:	BG25-MICI-03318
NRE:	030A50661204795
Cartella MICI:	MICI-BG-0417
Tessera sanitaria:	80380010401107373075

Prenotazione: BG25-MICI-03318

INQUADRAMENTO

La sig.ra Bianca Dell'Orto, 29 anni, è seguita presso il ns. Centro dal 2017 per malattia di Crohn ileocolica (classificazione di Montreal A2 L3 B2: fenotipo stenosante), diagnosticata dopo un episodio subocclusivo. Familiarità: la madre, sig.ra Ivana Rota, è affetta da rettocolite ulcerosa. Il pannello genetico eseguito nel 2018 ha evidenziato la variante NOD2 c.3019dupC (p.Leu1007fs) in eterozigosi. Pregressa gravidanza a termine nel 2021 con parto cesareo, in remissione clinica. Non fumatrice.

Terapie precedenti: mesalazina (inefficace), azatioprina sospesa nel 2018 per pancreatite acuta da farmaco, infliximab 2018-2022 con perdita di risposta e anticorpi anti-farmaco, quindi adalimumab 40 mg s.c. ogni 7 giorni dal marzo 2023. Dal mese di aprile riferisce ripresa di dolore crampiforme in fossa iliaca destra post-prandiale, 4-5 evacuazioni/die di feci non formate, calo ponderale di 5 kg in tre mesi. La paziente, Testimone di Geova, ha ribadito il rifiuto di trasfusioni di sangue ed emocomponenti, come già espresso nelle disposizioni anticipate di trattamento depositate il 14/02/2024.

ESAME OBIETTIVO

Condizioni generali discrete, cute e mucose pallide. Peso 51 kg, altezza 166 cm, BMI 18,5. PA 105/65 mmHg, FC 92 bpm, TC 37,1 °C. Addome trattabile, dolente alla palpazione profonda in fossa iliaca destra dove si apprezza una tumefazione di consistenza duro-elastica; Blumberg negativo, peristalsi presente. Regione perianale: non fistole né ascessi. Cicatrice di laparotomia trasversale sovrapubica (cesareo).

Prelievi del 12/03 eseguiti presso il punto prelievi di Seriate; prelievi odierni raccolti in sala prelievi dall'Inf. Marta Locatelli.

Indice / esame	12/03/2025	9 luglio 2025	Riferimento / note
Harvey-Bradshaw Index	4 punti	11 punti	> 8: attività moderata
Emoglobina (g/dL)	11,9	9,4	12,0 - 15,5
Ferritina (ng/mL)	31	7	15 - 150
PCR (mg/L)	6,8	38,5	< 5
Albumina (g/dL)	3,9	3,2	3,5 - 5,0
Calprotectina fecale (µg/g)	240	1.180	< 50
Livelli di adalimumab (µg/mL)	-	2,3 con anticorpi assenti	range terapeutico 5 - 12

ESAMI STRUMENTALI

Entero-RM del 24-06-2025 (acc. n. RM25-0088127): ispessimento parietale dell'ultima ansa ileale per circa 18 cm con stenosi serrata e dilatazione pre-stenotica a monte (calibro massimo 38 mm); non raccolte ascessuali né fistole.
Ileocolonscopia del 01.07.25 eseguita in sala endoscopica 2 dal Dott. Matteo Pesenti: stenosi della valvola ileocecale non superabile con lo strumento, ulcere aftoidi nel colon destro; biopsie coerenti con malattia di Crohn in fase attiva, negative per displasia. Tentativo di dilatazione endoscopica con palloncino non indicato per lunghezza della stenosi.

CONSULENZA MULTIDISCIPLINARE

Chirurgia colorettale

Valutata dal Dott. Davide De Santis: indicazione a resezione ileocecale laparoscopica elettiva, previa ottimizzazione nutrizionale e correzione dell'anemia. Rischio stimato di perdite ematiche significative basso (< 5%). La paziente è informata della possibile necessità di stomia temporanea in caso di condizioni locali sfavorevoli.

Anestesia - Patient Blood Management

Dott.ssa Chiara Lo Presti: programma di risparmio del sangue. ferro carbossimaltosio 1000 mg e.v. in unica dose; epoetina alfa 40.000 UI s.c. settimanale per 3 settimane; acido tranexamico intraoperatorio. La paziente accetta il recupero intraoperatorio del sangue in circuito chiuso e rifiuta emazie, plasma, piastrine e albumina.

CONCLUSIONI

Malattia di Crohn ileocolica in fase di attività moderata con stenosi fibro-infiammatoria dell'ileo terminale e perdita secondaria di risposta ad adalimumab; anemia sideropenica moderata; malnutrizione proteico-calorica lieve.

Piano

1. Sospendere adalimumab dalla data odierna.
2. Budesonide 9 mg 1 cp al mattino per 8 settimane, con successiva riduzione.
3. Nutrizione enterale integrativa con formula polimerica 600 kcal/die, secondo il piano della dietista, Dott.ssa Giulia Mazzoleni; dieta a basso residuo.
4. Infusione di ferro in Day Hospital il 16/07/2025; emocromo dopo 3 settimane.
5. Intervento di resezione ileocecale programmato in data 10 settembre 2025 (lista d'attesa chirurgica, classe A).
6. Terapia di mantenimento post-operatoria con ustekinumab da valutare a 4 settimane dall'intervento; compilato piano terapeutico AIFA n. PT-LOM-25-118402. Ileocolonscopia a 6-12 mesi per lo score di Rutgeerts.

Alla visita era presente il marito, sig. Samuel Okafor, che la paziente indica come persona di riferimento e che potrà ricevere informazioni cliniche (consenso firmato). Il sig. Okafor ha consegnato copia della tessera con le direttive anticipate, che viene allegata alla cartella. Le decisioni sulla gestione senza sangue sono state documentate e condivise con l'équipe chirurgica e anestesiologica.

Dirigente Medico - Centro MICI
Dott.ssa Elisa Nguyen
con il Dott. D. De Santis (Chirurgia) e la Dott.ssa C. Lo Presti (Anestesia)

Bergamo, 09/07/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO - DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI EMOTRASFUSIONE

Acquisita in sede di visita ai sensi della L. 219/2017

Io sottoscritta Bianca Dell'Orto, nata a Bergamo il 02.12.1995, dopo essere stata informata in modo chiaro e completo dalla Dott.ssa Elisa Nguyen e dalla Dott.ssa Chiara Lo Presti sui benefici e sui rischi della trasfusione di sangue e degli emocomponenti e sulle possibili conseguenze del rifiuto, compreso il pericolo di vita in caso di emorragia grave, dichiaro, per motivi di coscienza connessi alla mia fede, di:

- ☒ rifiutare emazie concentrate
- ☒ rifiutare concentrati piastrinici
- ☒ accettare il recupero intraoperatorio in circuito continuo
- ☐ accettare albumina
- ☒ rifiutare plasma fresco congelato
- ☒ rifiutare sangue autologo predepositato
- ☒ accettare fattori della coagulazione ricombinanti
- ☒ accettare emodiluizione normovolemica

Dichiaro inoltre di aver indicato quale fiduciario, ai sensi dell'art. 4 della L. 219/2017, il coniuge Samuel Okafor, nato a Lagos (Nigeria) il 17/05/1990, tel. +39 320 448 9031, e come sostituto la madre, Ivana Rota.

Ruolo	Nominativo	Firma
La paziente	Bianca Dell'Orto	
Il fiduciario	Samuel Okafor	
Testimone (infermiera)	Marta Locatelli	
Il medico che ha raccolto il consenso	Dott.ssa Elisa Nguyen	

ASST OROBICA OCCIDENTALE
CENTRO MICI
Dott.ssa E. Nguyen
Iscr. OMCeO BG n. 6104

Copia digitale - Dell'Orto B.:
https://fse.asst-orobica.example.it/doc/MICI-25-0709-0417

(1) La dichiarazione sostituisce quella del 14/02/2024, che resta agli atti; è revocabile in ogni momento dalla sig.ra B. Dell'Orto anche verbalmente.
(2) Copia consegnata alla paziente e trasmessa al Dott. Carminati (MMG) con il consenso dell'interessata.
(3) Harvey-Bradshaw Index: < 5 remissione, 5-7 attività lieve, 8-16 moderata, > 16 grave.